ONEMA-POP-001 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-001 — Identificação Precoce e Manejo de Suspeita

de Sepse no Atendimento Digital

Objetivo

1. Reconhecer deterioração compatível com infecção e possível disfunção orgânica, priorizando encaminhamento

seguro sem usar qSOFA isoladamente como porta de decisão.

Abrangência e competência

1. Atendimento remoto por enfermeiro habilitado, respeitando limites da telenfermagem; não substitui avaliação

presencial ou serviço de emergência quando indicado.

Materiais e recursos

1. Dispositivo com acesso seguro à Carteira Digital ONEMA e comunicação de contingência

2. Telefone para contato com paciente, responsável e SAMU 192

3. Dados confiáveis de temperatura, PA, frequência respiratória ou SpO■, somente se disponíveis

Preparação

1. Verificar conexão, identificação, consentimento/condições de privacidade, endereço para emergência e

disponibilidade de comunicação de contingência.

2. Não exigir que o paciente adquira materiais para uma triagem urgente.

Execução técnica — sequência padronizada

1. Confirmar identidade, localização atual e telefone para retorno; verificar se há acompanhante e possibilidade de

acionar emergência no endereço informado.

2. Perguntar qual infecção é suspeita ou conhecida, quando começaram os sintomas, evolução, tratamentos recentes,

internações e fatores de vulnerabilidade.

3. Avaliar consciência e orientação, padrão respiratório, perfusão aparente, coloração da pele e diurese referida; obter

sinais vitais apenas quando disponíveis e confiáveis.

4. Pesquisar ativamente confusão nova, falta de ar importante, sinais de choque, cianose, oligúria, deterioração rápida e

incapacidade de manter contato.

5. Diante de qualquer sinal de gravidade, orientar acionamento imediato do SAMU 192 ou serviço de emergência; não

aguardar completar questionário, aferições ou escore.

6. Enquanto o socorro é acionado, manter contato quando possível, orientar presença de acompanhante e posição de

conforto; não indicar antimicrobianos ou intervenções fora de prescrição.

7. Sem sinais imediatos de gravidade, definir necessidade e prazo de avaliação presencial conforme risco, evolução e

recursos disponíveis; orientar sinais de piora e retorno.

8. Registrar informações obtidas, fonte, limitações da avaliação remota, horário de identificação de alerta, decisão,

acionamento e confirmação de entendimento.

Intercorrências, interrupção e escalonamento

1. Alteração nova de consciência, sinais de hipoperfusão, dispneia importante, cianose, oligúria ou deterioração rápida:

emergência. Ausência de febre ou qSOFA baixo não exclui sepse.

2. Se a comunicação cair durante situação crítica, utilizar os contatos de contingência disponíveis e documentar as

tentativas; não registrar falsa confirmação de socorro.

Cuidados posteriores e continuidade

1. Confirmar entendimento do plano, orientar acompanhante/responsável quando apropriado e registrar destino do

encaminhamento se confirmado.

2. Na modalidade presencial, portar esfigmomanômetro validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; aferir conforme

indicação clínica.

Registros na Carteira Digital ONEMA

1. Registrar data e horário, identificação profissional, modalidade, informações e respectivas fontes, sinais e sintomas,

avaliação, diagnóstico e planejamento de enfermagem quando aplicáveis, ações, alertas, contatos, resposta e

continuidade.

2. Preservar a trilha de auditoria; a Kary pode organizar dados, mas não diagnosticar, prescrever ou decidir alta.

Referências técnicas

1. COFEN, Resolução 736/2024 — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

2. Surviving Sepsis Campaign, Guidelines 2021 —

https://www.sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/surviving-sepsis-campaign-international-guidelines